

Anticoncepción de emergencia

1. Introducción y relevancia clínica

La **anticoncepción de emergencia (ACE)** —conocida también como “píldora del día después”— consiste en el uso de métodos anticonceptivos **después de una relación sexual sin protección o con falla del método habitual**, con el objetivo de **prevenir un embarazo no deseado**.

Su eficacia depende **directamente del tiempo transcurrido desde la relación sexual**, siendo más alta si se administra dentro de las **primeras 24 horas**.

La **Norma Técnica MINSAL 2023** establece que la ACE **es un derecho garantizado** en todos los establecimientos de salud pública y privada, **gratuita para toda persona que lo solicite**, independiente de edad, previsión o circunstancia.

- En EUNACOM, las preguntas típicas incluyen:
 - “¿Cuál es el mecanismo de acción del levonorgestrel?”
 - “¿Hasta cuántas horas después de la relación puede usarse la anticoncepción de emergencia?”
 - “¿Qué método tiene mayor eficacia?”
 - “¿Produce aborto?” (respuesta: **no**).
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La anticoncepción de emergencia actúa **antes de la implantación**, interfiriendo con los procesos normales de ovulación, fecundación o transporte del óvulo fecundado.

a. Mecanismos de acción (según método)

Método	Mecanismo principal	Comentario
--------	---------------------	------------

Levonorgestrel (LNG)	Inhibe o retrasa la ovulación si se administra antes del pico de LH.	No afecta la implantación ni causa aborto.
Ulipristal acetato (UPA)	Modulador selectivo de receptores de progesterona → bloquea o retrasa la ovulación incluso si el pico de LH ya comenzó.	Más eficaz que LNG.
DIU de cobre (CuT-380A)	Efecto espermicida y citotóxico local → impide fecundación o implantación.	Método más eficaz (<0,1% de fallas).

□ **Ningún método de anticoncepción de emergencia es abortivo.**

Actúan **antes de la implantación**, por lo tanto, no interrumpen un embarazo establecido.

3. Indicaciones

- Relación sexual sin protección (olvido de píldora, rotura de condón, coito interrumpido fallido).
- Violación o agresión sexual.
- Error en el uso del método anticonceptivo habitual.
- Expulsión o retiro de DIU sin reemplazo inmediato.
- Cualquier situación de riesgo de embarazo no planificado.

4. Métodos disponibles y eficacia

Método	Dosis	Tiempo máximo de uso postcoital	Eficacia (%)	Observaciones
--------	-------	---------------------------------	--------------	---------------

Levonorgestrel (LNG)	1,5 mg VO (dosis única)	Hasta 120 h (ideal <72 h)	85–90	Disponible en sistema público. No interfiere con lactancia.
Ulipristal acetato (UPA)	30 mg VO dosis única	Hasta 120 h	95	Mayor eficacia, requiere receta médica. No usar en lactancia.
DIU de cobre (CuT-380A)	Inserción única	Hasta 5 días postcoito	>99	Método más eficaz; además brinda anticoncepción a largo plazo.

□ En EUNACOM:

“El método más eficaz de anticoncepción de emergencia es el **DIU de cobre** si se inserta dentro de los 5 días.”

5. Farmacología práctica

a.

Levonorgestrel (LNG)

- Derivado sintético de la progesterona.
- Dosis única de **1,5 mg VO** o dos dosis de **0,75 mg con 12 h de intervalo**.
- Idealmente antes de 72 horas, aunque conserva cierta eficacia hasta 120 horas.
- Eficacia disminuye si se administra después de la ovulación.

b.

Ulipristal acetato (UPA)

- Antagonista parcial de los receptores de progesterona.
- Más eficaz que el LNG entre 72 y 120 h postcoito.

- Inhibe la ovulación incluso si el pico de LH ha iniciado.
- No debe combinarse con métodos hormonales dentro de los 5 días siguientes (interacción competitiva).

C.

DIU de cobre

- Inserción intrauterina hasta 5 días después de la relación sexual.
- Previene fecundación y puede impedir implantación al modificar el endometrio.
- Se mantiene luego como método anticonceptivo continuo.

6. Eficacia comparada

Método	Tasa de embarazo (%)	Ventajas principales	Desventajas
DIU de cobre	0,1	Más eficaz, anticoncepción prolongada	Requiere inserción por profesional
Ulipristal	1–2	Alta eficacia hasta 5 días	Requiere receta, no apto en lactancia
Levonorgestr el	1,5–3	Fácil acceso, disponible en servicios de urgencia	Menor eficacia si >72 h o IMC alto

En mujeres con **IMC >30**, el levonorgestrel puede perder eficacia; se prefiere **ulipristal o DIU de cobre**.

7. Efectos adversos

Efecto	Frecuencia	Manejo
Náuseas o vómitos	15–20%	Si vomita antes de 2 horas, repetir dosis
Cefalea, mareo, fatiga	10–15%	Transitorio
Alteración menstrual (retraso o adelanto)	20–30%	Normal, suele resolverse siguiente ciclo
Dolor mamario o pélvico leve	10%	Sintomático

Si la menstruación **se retrasa más de 7 días**, debe realizarse **test de embarazo**.

8. Contraindicaciones

a.

Levonorgestrel y ulipristal

- Embarazo confirmado.
- Hipersensibilidad conocida al principio activo.
- Enfermedad hepática grave.

b.

DIU de cobre

- Embarazo o sospecha.
- Infección pélvica activa.
- Malformación uterina grave.

- Cáncer cervical o endometrial.

En caso de violación, se prioriza **método oral inmediato** y se evalúa **DIU de cobre posterior** si la paciente lo desea.

9. Conducta posterior a la administración

1. **Explicar posibilidad de cambios menstruales.**
 2. **Evitar relaciones sexuales sin protección** durante el mismo ciclo.
 3. **Iniciar método anticonceptivo regular** tan pronto como sea posible:
 - Después de **levonorgestrel**: puede comenzar AOC o progestina de inmediato.
 - Después de **ulipristal**: esperar 5 días antes de iniciar método hormonal.
 - **DIU**: ya actúa como anticonceptivo continuo.
 4. **Test de embarazo** si no hay menstruación dentro de 3 semanas.
-

10. Anticoncepción de emergencia en Chile (Norma MINSAL 2023)

- Disponible **gratuitamente en todos los CESFAM, hospitales y SAPU.**
- Se entrega **sin restricción de edad y sin requerir denuncia previa en casos de violación.**
- Personal de salud debe garantizar:
 - Confidencialidad.
 - Orientación sobre opciones anticonceptivas.
 - Registro en ficha clínica.
 - Oferta de consejería y control posterior.

☐ Según MINSAL, la entrega debe realizarse **inmediatamente tras la solicitud**, sin exigir orden judicial ni consentimiento parental en menores.

11. Mitos frecuentes (y aclaraciones)

Mito	Realidad
“La píldora del día después es abortiva.”	Falso. Actúa antes de la implantación.
“No se puede usar más de una vez.”	Falso. Puede usarse nuevamente si hay riesgo, aunque se recomienda iniciar anticoncepción regular.
“Causa infertilidad.”	Falso. No altera fertilidad futura.
“Solo se puede usar dentro de 24 horas.”	Falso. Eficaz hasta 120 horas (mejor antes de 72).
“No se puede usar en lactancia.”	Falso para levonorgestrel; verdadero para ulipristal.

12. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐

Perlas

1. El **mecanismo principal del levonorgestrel** es **inhibir o retrasar la ovulación**.
2. **No es abortiva**: no afecta un embarazo ya implantado.
3. **Tiempo máximo**: 120 horas postcoito, ideal <72 h.

4. **Método más eficaz:** DIU de cobre.
5. **No requiere examen previo ni receta médica** para su entrega en sistema público.
6. **Efectos secundarios leves y transitorios.**
7. **Ulipristal** mantiene eficacia más allá de 72 horas, pero **no se usa junto con otros métodos hormonales inmediatos.**



Errores comunes

- Administrar levonorgestrel después de 5 días (ya sin eficacia).
- Indicar ulipristal en mujeres lactantes.
- No recomendar anticoncepción regular posterior.
- Confundir anticoncepción de emergencia con aborto farmacológico.
- No descartar embarazo previo ante atraso menstrual prolongado.

13. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **anticoncepción de emergencia** previene el embarazo tras relaciones sin protección o falla del método.
2. Métodos disponibles: **levonorgestrel (oral), ulipristal (oral) y DIU de cobre.**
3. Mecanismo principal: **inhibición o retraso de la ovulación (no abortiva).**
4. Eficacia mayor si se usa <72 h; el **DIU de cobre es el más eficaz** (hasta 5 días).
5. Efectos secundarios leves: náuseas, alteraciones menstruales.
6. **Levonorgestrel puede usarse en lactancia; ulipristal, no.**
7. Debe ofrecerse de forma **gratuita e inmediata** en todo establecimiento de salud según **MINSAL 2023.**